جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ماجده عبد العزيز محمد عبد اللطيف
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الاخصاص **العنوان :** =
رقم البطاقة : 26211252101887 **رقم التليفون :** 01114702392 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 14-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-11-1962 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ماجده عبد العزيز محمد عبد اللطيف
National ID: 26211252101887

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٠١١٤٧٠٢٣٩٢

٠١١٤٥١٧٣٤٣٩



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	:الأستاذه / ماجده عبدالعزيز محمد عبداللطيف	Request No.	: 13006093
Patient No.	: 26211252101887	Request Date	: 5/11/2025
Path No.	: 2276/25	Verification Date	: 9/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	:جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	:Mrs.Mayada Hegazy

Molecular Testing Report

Clinical Data: Metastatic adenocarcinoma of GIT origin
Nature of specimen: Tru cut biopsy.

Gross Examination:
Paraffin block received by Inter Mark. H&E stained slide is prepared, examined by pathologist and confirmed that block contains tumor matching with the requested test
• **Test(s) requested:** KRAS, NRAS and BRAF Gene, Mutation testing.

Methodology and Limitations:
Method Limitation: The designed primers used in this method and the analysis pipeline are capable of detecting KRAS codons 12, 13, 60, 61, 117 and 146, NRAS codons 12, 13, 60, 61 and 146, and BRAF codon V600E mutations only.
Limit of detection:
- Sensitivity of KRAS-G12D, KRAS-G12A, KRAS-G12V, KRAS-G12S, KRAS-G12R, KRAS-G12C, KRAS-G13D, KRAS-G13C, KRAS-Q61L, KRAS-A146, NRAS-G12D, NRAS- G12S, NRAS-G13D, NRAS-G13R, NRAS-G12C, NRAS-G12V, NRAS-G12A, NRAS-G13V, NRAS-Q61L, NRAS-Q61H and NRAS-K117N mutations are 1% in a background of 99% normal DNA at 10 ng sample DNA amount.
- Sensitivity of KRAS-Q61R, KRAS-Q61H, NRAS-Q61R, NRAS-Q61K & NRAS-A146T mutations are 2% in a background of 99% normal DNA at 10 ng sample DNA amount.
- Sensitivity of KRAS- K117N, KRAS- A146T, KRAS- A146V and BRAF V600E mutations are 5% in a background of 99% normal DNA at 10 ng sample DNA amount.

Indication: Predictive test for response to therapy.

Gene	Result	Mutation Detected
KRAS	Mutant	Mutation detected in Exon 2
NRAS	Not Tested	---
BRAF	Not Tested	---

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: ماجده عبدالعزيز محمد	
MR. : 9173	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 63-year-old individual with a history of synchronous breast and colon cancers. Initial staging in 2020 documented a T2N1 breast carcinoma (ER 8/8, PR 6/8, HER2-negative) treated with right mastectomy, axillary node dissection (1/12 nodes positive), adjuvant radiotherapy, and 2 years of tamoxifen. In 2024, the patient commenced fulvestrant (FEMARA) and continued through 6 2025. A triphasic CT in 2026 revealed a 10 × 9 × 15 cm HFL mass and a 15 × 11 × 15 cm rectosigmoid lesion, consistent with metastatic adenocarcinoma of upper GI origin. Molecular testing identified a KRAS exon 2 mutation; NRAS and BRAF were not tested. The patient received five cycles of XELOX (capecitabine/oxaliplatin) with a dose of 130 mg/m² oxaliplatin. Subsequent imaging on 7 Feb 2026 showed no change in the HFL mass but noted peritoneal nodules; the MDT recommended adding bevacizumab to XELOX for the next cycle. On 14 May 2026, the MDT approved bevacizumab with XELOX for cycle 8, prescribing oxaliplatin 200 mg/m² (weight 60 kg, height 160 cm, SA 1.6) and fulvestrant. On 3 Jun 2026, due to rectal bleeding, bevacizumab was postponed for cycle 9, and the regimen was adjusted to XELOX, oxaliplatin 200 mg/m², fulvestrant, calcium, and vitamin D. A CT on 13 Jun 2026 reported progression in the liver and rectosigmoid mass, with new lung nodules; the MDT discussed fulvestrant and supportive care. On 8 Aug 2026, an MDT evaluated transvaginal ultrasound findings of uterine lesions; FOLFIRI with bevacizumab was considered, but bevacizumab approval was pending. A port-catheter was planned for cycle 1 day 1 of FOLFIRI. On 26 Aug 2026, the patient was evaluated for possible surgical intervention for intussusception and uterine lesions; due to lack of bevacizumab approval, the plan was to shift to FOLFIRI-bevacizumab for cycle 1 day 15, with a 10 % dose reduction of FOLFIRI because of vomiting. A pharmacy note on 26 Aug 2026 documented a hemoglobin of 7.4 g/dL (post-transfusion), bilirubin 1.9 mg/dL, and a 25 % dose reduction of camptothecin. On 9 Sep 2026, the patient experienced diarrhea and fatigue during cycle 2 day 1 of FOLFIRI, receiving camptothecin 228 mg, levamisole 510 mg, and a total FOLFIRI infusion of 3072 mg, with concurrent fulvestrant, calcium, and vitamin D. The patient has completed 2 cycles of FOLFIRI.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name	الأستاذه / ماجده عبدالعزيز محمد عبداللطيف:	Request No.	: 13006093
Patient No.	: 26211252101887	Request Date	: 5/11/2025
Path No.	: 2276/25	Verification Date	: 9/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	جوستاف روسي - نفقة الدولة:
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Molecular Testing Report

Interpretation & Comment

Based on the current results This patient should not be considered for anti-EGFR monoclonal antibody targeted therapy because as per the NCCN guidelines Colorectal tumors with any known KRAS mutation (exon 2, 3, 4) or NRAS mutation (exon 2, 3, 4) are associated with lack of clinical response to anti-EGFR.

Test Background

Approximately 40% of patients with mCRC harbor an activating KRAS & NRAS mutations in 4% of the patients. The outcome of patients with RAS mutations is worse compared to RAS wild type (RAS wt) cases. However, KRAS & NRAS mutations also have distinct impacts on survival in mCRC; the prognosis of the aggressive NRAS mutant molecular subset is poor.

According to National Comprehensive Cancer Network guidelines (NCCN; Version 1.2020) for metastatic colorectal cancer (mCCR), expanded RAS panel for activating mutation of KRAS & NRAS is crucial at time of diagnosis to select the patients who are likely to benefit from anti-EGFR therapies.

Test Description

- Tissue sections were reviewed by a pathologist and relevant tumor was selected for analysis.
- DNA was isolated and amplified by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) using NRAS and KRAS CE-IVD kits according to manufacture protocol. results interpreted according to the manufacture user guide. Mutation nomenclature was performed considering the following reference sequences: NM_004985.4 (KRAS) and NM_002524.4 (NRAS gene).
- BRAF V600E mutation specific Competitive allele specific TaqMan assay along with its reference wildtype assay were performed for each sample to accurately interpret the results.

Disclaimer:

- The molecular testing reported herein was performed at an external reference lab (57357 molecular laboratory).

Signature

Prof. Dr. Maha Guimei

CAP ACCREDITED

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Medical No. : 10296
Patient's Name: Magda Abdul Aziz Mohammed
Date: 2026-09-23
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Color Duplex scanning of the port-A-Cath revealed: -

- *Port-A-Cath is seen introduced through the left IJV identified by two echogenic lines*
- ***The left IJV is mildly dilated partially compressible showing adherent echogenic thrombus attached to its anterior wall consistent with subacute partial thrombosis***
- *The port-A-Cath pocket is seen at the right infra clavicular region with no related collection or hematoma.*

DR: Nermeen Ramadan.MD

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Pa
MI

الرقم الطبي:	9173
اسم المريض:	ماجده عبدالعزيز محمد /
تاريخ الميلاد:	25/11/1962
الرقم الطبي القديم:	null

Blood Transfusion Monitoring Form

Date of delivery: 26../..8../26 Time of delivery: 10..17 Transfusion start time: 12: 45 End Time: ... : ...

Blood Group & RH Type: ..(O)..Type of blood unit: ..(O)..Blood unit No: .....

Blood unit double checking:	☐ Assigned nurse	Name & ID: Mon... Signature: Mon...	☑ Charge Nurse	Name & ID: Azza... Signature: Azza...
Patient Identification double checking (bedside):	☑ Assigned nurse	Name & ID: mon... Signature: mon...	☑ Charge Nurse	Name & ID: Azza... Signature: Azza...

Nursing Observation: ☑ No reaction ☐Reaction (Rash, Fever, Shivering, Facial edema, Laryngeal Spasm, ...)

If reaction, Notified to: .....Time: ... : ... Documented in Blood Transfusion Reaction Form ☐ Yes ☐ No

	Time	Temp.	Pulse	SPO2	RR	BP	Pain
Baseline vital signs	12:45	35,5	95	98	17	120/60	0
After 5 minutes	12:50	35,5	98	97	17	114/65	0
After 10 minutes	1:00	35,2	97	98	17	125/75	0
After 15 minutes	1:15	35,1	98	97	17	115/65	0
After 30 minutes	1:30	35,2	97	98	17	116/75	0
After 45 minutes	1:45	35,5	98	97	17	126/78	0
After 60 minutes	2:00	35,2	97	98	17	110/65	0
After 90 minutes	2:30	36,2	98	97	17	120/70	0
After completion of transfusion	2:30	36,2	98	97	17	110/60	0
After 5 minutes from completion of transfusion	2:35	35,9	98	98	17	120/75	0
After 1 hour from completion of transfusion	3:35	36,2	98	97	17	110/60	0
After 2 hours from completion of transfusion	4:35	36,2	98	97	16	125/70	0

Nurse Name & ID: Mon... Signature: ..... Date: 26../..8../26... Time: .....: .....

Mon...

* Use separate form for each unit transfused.

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

DOCTOR'S ORDERS

الرقم الطبى:	9173
اسم المريض:	ماجده عبدالعزيز محمد /
تاريخ الميلاد:	25/11/1962
الرقم الطبى القديم:	null

Diagnosis: ..... Unit: ..... Diet Type: .....

Date	Time Of Order	Doctor's Order	Physician Name & ID	Signature	Nurse Name & ID	Signature	Time of Order Execution
		Breast + Colon					
		بعد التوافر	نقل دم				
			على مدار				
			Hb = 7				

* All orders, modifications, discontinuations, and corrections should be dated, timed, and signed.
* Do NOT use abbreviations.
*This form is NOT intended for use for medications orders.

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPTE

الرقم الطبى:	9173
اسم المريض:	ماجده عبدالعزيز محمد /
تاريخ الميلاد:	25/11/1962
الرقم الطبى القديم:	null

Blood /Blood Components Transfusion Consent
اقرار بالموافقة على نقل الدم / مشتقاته

انا الموقع ادناه (المريض/ ممثل القانونى) ماجدة عبد العزيز محمد ..... رقم قومي / جواز سفر ٢٥١١٢٥٢١٠١٨٨٧

الرقم الطبى : ..... التشخيص: .....

انى قد وافقت على اعطاء الدم و/او احد مشتقاته و ذلك بعد ان قام الطبيب بشرح ما يلى بشكل واضح و مفهوم:

١- سبب الحاجة الى نقل الدم فى حالات:

أ- نقل خلايا الدم الحمراء: في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.

ب- نقل الصفائح الدموية: لتعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية

ج- نقل البلازما: تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبًا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.

٢- الفوائد المتوقعة من هذا الاجراء

٣- المخاطر و المضاعفات المحتملة بما فى ذلك:

أ- ردود الفعل التحسسيةو التى قد تشمل قد تشمل طفح جلدي، حكة، أو تورم.

ب- ارتفاع درجة الحرارة.

ج- العدوى النادرة بامراض فيروسية و بكتيرية.

د- مشاكل في القلب أو الرئة نتيجة فائض السوائل أو التحسس الشديد، تفاعل مع خطأ في المطابقة أعراق الدم، مما قد يؤدي إلى تفاعل جسدي شديد.

هـ- حدوث فرط الحديد: قد يتسبب فرط الحديد بتلف في مناطق وأعضاء مختلفة من الجسم إن لم يتم تداركه وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إن حدث في القلب أو الكبد.

و- لإصابة بمشكلات صحية في الرئتين، مثل: إصابة الرئة المتعلقة بنقل الدم، وهو مرض نادر قد يتسبب بتلف الرئة والوفاة.

٤- البدائل الممكنة لنقل الدم ان وجدت.

٥- حقى فى طرح الاسئلة و الحصول على الاجابات الكاملة قبل اتخاذ القرار.

اقر انا المقع ادناه بانى على كامل المعرفة و الفهم لكل مشتملات هذا الاقرار و اتحمل المسؤلية كاملة عن كل ما فيه

أسم المريض (او ممثله القانونى): عبد العزيز شحاته محمد ..... اسم الطبيب المعالج/ الرقم الوظيفى: .....

درجة القرابة: ابنه ..... التوقيع: .....

رقم قومي / جواز سفر: ٢٥٩٠٩٢١٠١٤٥٩ ..... التاريخ/ الوقت: ٨/١/٢٠٢٦ .....

التوقيع: : عبد العزيز شحاته محمد .....

اسم الشاهد: : .....

التاريخ/ الوقت: ٨/١/٢٠٢٦ .....

رقم قومي / جواز سفر: .....

التوقيع: : .....

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

Patient name:	ماجده عبدالعزيز محمد
MRN:	5446/2020
نفقة دولة نقدى	

Blood Delivery form

	Components	Amount		Order Status	Time of Order
☐	Whole blood		☐	Scheduled	
☐	Packed RBCs		☐	Emergency	
☐	Filtered Packed RBCs		☐	High Emergency (withou tcross matching)	
☐	Irradiated Packed RBCs	One Unit	☐		
☐	Fresh Frozen Plasma		☐		
☐	Platelet concentrate		☐		
☐	Cryo precipitate		☐		
☐	Irradiated Platelet		☐		

Time of Delivery of Blood Components: 12:28:11 م

Blood Group: (O) RH Group (D antigen): Positive

Antibody Screening: ----------

Cross Matching: Matched

Bag No.:

2614	A3970258
Donation time	EXPIRATION DATE
11/8/2026	15/9/2026

Donation time	EXPIRATION DATE

Blood Bank Physician Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
NYRAA SAYED	NYRAA SAYED	26-2026-أغسطس	12:28 م

Assigned Nurse/ Healthcare Assistant Name & ID	Signature	Date of Delivery	Time
		26-2026-أغسطس	12:28 م

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

26211252101887

Patient Name:
MRN:

Blood/ Blood Components Request

Room no:	Sex: ☐ Male ☐ Female	Age:
Diagnosis:		
Indication for transfusion:		
History of Previous Blood Transfusion:	☐ No ☐ Yes	
History of Previous Blood Transfusion Reaction:	☐ No ☐ Yes, specify.....	

Number of Units Needed:

- ☐ Whole Blood..... Units
- ☐ Packed Cells..... Units
- ☐ Platelets.....Units
- ☐ F.F.P..... Units
- ☐ Cryoprecipitate..... Units
- ☐ Auto transfusion..... Units
- ☐ Other: ..... Units

To be delivered to:

- ☐ OR
- ☐ ED
- ☐ ICU
- ☐ BMT

Urgency:

☐ **Immediate**: Needed in less than 20 minutes (Without compatibility testing).

☐ **Urgent**: Cross matching tests take **1 hour**

☐ **Routine**: compatibility test take two hours

Frequency of Transfusion:

Requesting Physician Name & ID:	Signature:	Date:	Time:
Sample taken by (nurse) Name & ID:	Signature:	Date:	Time

For Blood Bank:

Date	Blood Group	Bag no.	Time	Name & ID	Signature
26-8	opos	2814	12:16		